

5장 출산교육

● 학습목표

- 출산 및 부모교육의 중요 원리를 설명한다.
- 출산 및 부모교육의 구체적 내용을 설명한다.
- 다양한 출산 및 부모교육 방법을 열거한다.
- 출산 및 부모교육 프로그램을 계획한다.

● 주요 목차

1. 분만법의 종류와 그에 필요한 훈련
2. 산전교육프로그램의 실제

● 주요 용어

국제출산교육협회	International Childbirth Education Association, ICEA
둘라식 분만	doula type delivery
라마즈 분만	Lamaze childbirth
르보이에 분만	Leboyer birth
삼중표지자검사	triple marker screening test
소프롤로지식 분만	Sophrology
수중 분만	water birth
아로마테라피	aromatherapy
연상법	imagery
이완법	relaxation method
지압	acupressure
출산 및 부모교육	childbirth and parenting education
치료적 접촉	therapeutic touch
태교	Taegyo

임신과 출산은 정상적인 생리과정이지만 임부와 태아를 포함한 가족에게 발달적 위험을 초래할 수 있다. 따라서 간호사는 임부와 가족의 신체적, 심리사회적, 영적 문제를 사정함으로써 그들에게 적절한 교육 및 상담을 제공해야 한다. 출산교육자로서 간호사는 출산교육의 질적 수준을 유지하고 임부와 배우자를 출산교육에 참여하게 하며, 임신과 출산과정 및 이후 자녀양육을 부부 및 가족의 공동과제로 받아들여 함께 대처해나갈 수 있도록 도와야 한다.

국제라마즈협회(Lamaze International, 2000)의 출산 철학에 의하면 출산과정 동안 여성은 깨어 있으며, 출산 중 일어나는 과정을 알고, 가족이나 친구에 의해 지지를 받으면서 아기와 함께하기를 원하고 있다. 이를 위한 준비로 출산교육자는 여성과 가족이 정상적(normal)이고 자연적(natural)이며 건강하고 행복한 출산 경험을 할 수 있도록 교육, 옹호, 개혁하는 역할을 해야 한다. 여성은 출산교육을 통하여 관련된 정보에 따라 스스로 선택하고, 자신에게 내재하는 지혜를 신뢰하는 힘을 갖게 되며, 임신이라는 발달적 위기에 긍정적이고 적극적으로 대비하고 참여할 수 있게 된다.

1. 분만법의 종류와 그에 필요한 훈련

출산 및 부모교육은 기관에 따라 다양하다. 이 중 한 가지의 방법을 선택하거나 통합된 교육프로그램을 개발하여 출산교실에서 교육할 수 있다. 출산교실은 병원 출산에 의해 발생하는 부작용을 감소시키고, 자연적인 출산의 이점을 증진하고자 하는 운동에서 비롯되었다. 이는 임부와 가족에게 임신과 출산의 생리, 과정 및 대처방법에 관한 정보를 제공함으로써 임신과 출산에 대한 공포를 감소시키면 출산 중 근육의 긴장과 통증은 적어질 것이라는 원리에 기초하고 있다. 성공적인 출산 경험을 한 여성들이 조직한 단체가 건강전문가들을 도

와 임신부들을 가르치고 지지하기 시작한 것이 오늘날 운영되고 있는 출산교실의 시초이다. 관련된 이론과 학자는 다음과 같다.

- Dick Read(1959)는 공포-긴장-통증의 순환을 설명하였다. 임부에게 적절한 산전정보를 제공하여 출산에 따른 공포가 감소하면 근육의 긴장 정도가 감소하고 그 결과 통증을 감지하는 정도도 변화한다는 이론으로서 신체는 물론 정신의 이완에 초점을 두고 있다.
- Lamaze(1891~1957)는 Pavlov의 연구결과를 바탕으로 통증에 대처하기 위한 사전 조건반사의 효과를 제시하였다. 즉, 통증과 자궁수축은 정신으로 연결되는 별개의 현상이라는 것에 초점을 두어, 출산교육을 통해 산부가 갖는 부정적 지각(negative perception)을 교정하고, 자궁수축에 대한 반응으로 호흡법과 이완요법을 훈련시킴으로써 대뇌피질에 대한 자극을 차단시켜, 통증에 대한 자각을 감소시킨다는 이론을 성립하였다.
- Bradley(1965)는 출산을 위한 이완요법과 호흡법을 가르치면서 남편의 역할을 강조하고 남편과 이 방법을 함께 하도록 하는 것에 대한 효과를 제시하였다. 출산준비의 기본원리는 산부가 출산에 대하여 갖고 있는 두려움, 불안, 공포가 긴장을 유발하고 긴장은 통증을 심화시킨다는 가설에 근거한 것으로, 이 악순환의 고리를 깨뜨리려는 의도적인 시

도가 출산교육의 목적이라고 하였다.

출산을 위한 산전교육은 학자에 따라 그 방법과 이론적 개념의 기술이 조금씩 다르지만 기본적인 목표는 인지적인 측면으로 임신, 출산에 대해 정보를 제공하는 것이다. 또한 생리적인 측면으로는 분만 통증 경감, 출산 시간 단축, 그리고 합병증 예방이며, 정서적인 측면으로는 임신, 출산, 산육에 대해 긍정적인 경험과 태도를 갖게 하는 면에서 일치한다고 본다.

1) 라마즈 분만법

라마즈 분만법(Lamaze childbirth)은 Pavlov의 조건반사에 근거하여 러시아 의사들에 의하여 고안되었고, 1951년 프랑스의 의사 라마즈 박사에 의하여 정리되고 전파되었다. 라마즈 분만법의 주된 목적은 진통 및 출산 시의 고통을 경감시키고 출산이 보다 즐겁고 좋은 추억이 되도록 하는 것이다. 고통에 대한 감수성을 낮추는 정신예방적인 훈련으로서 자궁수축이 시작되면 호흡법 및 이완법, 연상법을 이용하여 통증에 대한 감각을 완화시키고자 하는 것이다.

(1) 연상법

연상법은 기분이 좋거나 행복했던 상황을 머릿속에 떠올리는 것이며, 동적인 것보다는 주로 평화롭고 조용한 정적인 경험을 연상하게 한다. 그 예로 연애시절의 기억, 한가한 바닷가에서의 휴가, 노을진 저녁 나절, 아기에 대한 상상, 조용한 음악, 기도문 암기 등을 들 수 있다. 이는 체내에서 엔돌핀 분비를 증가시키고, 이로써 통증을 감소시키는 효과가 유발된다.

(2) 이완법

진통으로 온몸이 경직되면 근육에 젖산이 축적되어 피로가 쌓이며 통증이 더욱 심해진다. 전신 이완은 출산에 도움이 되지만 온몸을 이완하기란 그리 쉬운 일이 아

니다. 특히 출산 시에는 공포, 불안 및 자궁근육 수축과 관련되어 전신이 긴장된 상태가 되므로 출산 전부터 이완하는 연습을 반복적으로 해야 한다.

이완법은 머리끝부터 발끝까지 온몸의 힘을 빼는 것이다. 주로 좌측위를 취하고 발끝에서 머리까지 점진적으로 이완하는 훈련을 한다. 이 방법은 전신적 이완이 릴랙신(relaxin)이란 물질을 분비시켜 이완을 촉진하는 효과가 있다고 본다. 배우자나 출산 조력자에게 이완이 잘 되었는지 여부를 확인하는 방법을 알려주어 일상생활 중에도 충분히 이완하는 훈련을 반복적으로 할 수 있도록 지도한다. 성공적인 이완이 된 경우는 상대방이 팔과 다리 등의 이완 부위를 들었을 때 무게를 적게 느끼게 된다.

(3) 호흡법

라마즈 호흡법은 흉식호흡을 기본으로 한다. 자궁수축 시에 산소를 충분히 공급하고, 동시에 근육 및 체내 조직의 이완을 도모하며, 불규칙해지는 호흡을 바로잡아 산모와 태아에게 산소공급을 원활히 할 뿐 아니라 통증에 집중된 관심을 호흡 쪽으로 전환시키려는 데 목적을 둔다. 호흡법을 수행하기 위해 평상시 임부의 호흡수를 알아두어야 한다. 호흡법은 이완이나 연상법을 동시에 사용할 때 효과를 극대화할 수 있다.

① 심호흡

자궁수축이 시작되면 심호흡(cleansing breathing)을 한 번 한 후 다음에 열거한 호흡법을 시작하고 자궁수축이 끝나면 다시 한 번 심호흡을 한 후 다음 수축 시까지 휴식을 취한다. 이는 얇은 흉식호흡에 앞서 모성과 태아에게 충분한 산소를 확보하기 위함이다.

② 느린 흉식호흡

느린 흉식호흡(slow paced breathing)은 가장 편이

하고 이완이 잘 되는 호흡법이다. 분만 초기에는 이 호흡법을 적용하면서 견딜 수 있을 때까지 이 방법을 유지하는 것이 좋다. 느린 흉식호흡은 평상시 호흡의 1/2의 깊이로 호흡수는 1/2로 천천히 호흡하는 것이다. 예를 들어, 평상시 호흡수가 1분에 16회 정도인 여성이라면 1분에 8회 정도로 천천히 얇은 흉식호흡을 하는 것이다. 대부분의 산부는 자궁경부가 3cm 정도 개대되는 시기까지 느린 흉식호흡을 효과적으로 지속할 수 있다. 호흡의 깊이가 얇기 때문에 자궁수축의 시작과 끝에 심호흡을 하는 것을 반드시 주지시켜야 한다.

③ 규칙적인 빠른 흉식호흡

(modified paced breathing)

자궁경관이 3~7cm 정도 개대될 때 산부는 당황하여 호흡을 조절하기 어려워지므로, 평상시 호흡수의 2배의 속도로 얇은 흉식호흡을 한다. 예를 들어, 평상시 호흡수가 1분에 16회 정도인 여성이라면 1분에 32회 정도로 빠르고 얇은 흉식호흡을 하는 것이다. 산부가 어지럽다고 하면 과호흡으로 인한 호흡성 알칼리증의 가능성이 있으므로 곧 종이봉투를 이용하거나 손을 컵 모양으로 만들어 자신이 뿜은 CO₂를 포함한 호기를 되마시게 하면 즉시 증상이 완화된다. 이 호흡도 반드시 심호흡으로 시작하고 마쳐야 한다. 이 호흡은 히-히-히 소리를 내며 호흡을 하면 쉽게 따라 할 수 있다.

④ 수정된 빠른 흉식호흡

(patterned paced breathing)

자궁경부가 7~10cm 개대되는 이행기에는 더 이상 규칙적인 빠른 흉식호흡으로 통증을 조절할 수가 없다. 이 시기의 호흡 패턴과 호흡수는 규칙적인 빠른 흉식호흡과 동일하지만 옆에서 남편이나 간호사가 손가락으로 히-히-히-후-히-히-히-후 등의 호흡패턴을 지시해주면서 호흡수가 너무 빨라지지 않도록 안내해준다.

보통은 “후” 호흡을 심호흡으로 혼동하는데 “히” 호흡이나 “후” 호흡의 깊이와 호흡수는 동일하다. 이 시기의 호흡을 성공적으로 이끌기 위해서는 배우자나 분만 조력자의 훈련이 필수적이다.

⑤ 분만 2기 호흡

자궁경부가 완전 개대되어 아기 머리가 보이는 분만 2기가 시작되면 자궁수축과 동시에 온 힘을 모아서 밀어내며 힘을 주는 밀어내기 호흡법을 이용한다. 이 호흡은 자궁수축이 시작되면 2회 심호흡을 하는데 두 번째 호흡을 깊이 들이마신 후에는 내쉬지 않고 하나에서 여덟 정도까지를 헤아리면서 온 힘을 다하여 내미는 동작을 한 후 내쉰다. 다시 한 번 깊게 들이마신 후 내쉬지 않고 동일하게 밀어내기 동작을 하고 내쉬고 다시 깊게 들이마신 후 밀어내기를 하고 내쉬는 것을 세 번 정도 한 후 자궁수축이 끝나면 심호흡으로 마치게 된다. 이 시기의 호흡은 모태아 순환을 원활히 하기 위하여 입을 벌리고 힘을 주는 개방식 호흡을 유지하는 것이 중요하다.

2) 소프롤로지식 분만법

소프롤로지(Sophrology)식 분만법이란 조화, 평온, 평안, 안정을 의미하는 Sos와 심기, 영혼, 정신, 의식을 의미하는 Phren, 학술이란 의미의 Logos의 합성어로 이루어져 정신의 평안과 안정, 조화를 얻기 위한 방법을 배우는 것으로 1960년에 스페인의 Alfonso Caycedo가 창안하였다. 이러한 소프롤로지를 1976년 프랑스의 Jeanne Creff 박사가 산과 영역에 도입하기 시작하였다. 소프롤로지 분만법의 특징은 동양적 사고에 기초한 소프로리미널 상태의 영상훈련법과 복식호흡법을 사용하며, 좌산, 반좌산의 자세를 취하는 것이다.

소프롤로지의 기본은 영상훈련을 통해 잠들기 바로 직전의 상태로 의식을 가라앉혀 출산 시 일어날 일들을

미리 훈련하는 것이며, 소프롤로지식 체조로 의식을 명상상태로 안정시켜 근육을 이완시키도록 하며, 복식호흡을 기본으로 한 소프롤로지식 호흡법으로 분만 시 태아에게 산소를 충분히 공급하고 자궁의 활동을 촉진한다.

(1) 영상훈련

소프롤로지 분만은 통증을 피하고 싶은 불쾌한 문제로 보기보다는 그 문제를 받아들이고 적극적으로 대처하려는 긍정적 인식에 기초하고 있다. 음악을 들으면서 앞으로 일어날 일들을 긍정적으로 상상하고 두려움과 불안을 없애며, 적극적인 사고를 갖도록 훈련한다.

(2) 근육이완훈련

근육이완훈련은 근육과 관절을 의도적으로 긴장시키고 이완시키며 그 차이를 인식함으로써 근육의 긴장과 이완을 조절할 수 있도록 하는 것이다. 음악을 들으면서 소프로리미널 상태에서 이완훈련을 할 수 있는데 의식을 집중하여 근육의 긴장과 이완의 감각을 익히도록 한다. 근육을 이완시키기 위해 매일 근육이완훈련을 하는 것이 필요하다.

(3) 호흡법

소프롤로지식 분만법의 기본호흡은 복식호흡이다. 자율신경계를 안정시키고, 산소를 체내에 충분히 공급하여 근육활동을 돕고, 진통 시 호흡을 내쉬고, 아래로 힘을 줄 때에도 숨을 내쉬으로써 태아에게 산소공급을 적절히 하고자 하는 것이다.

3) 둘라식 분만법

출산 진통과 출산 소요시간을 감소시키는 가장 성공적인 방법 중의 하나는 부드러운 말로 위안과 격려를 주고 임산부를 마사지하며 부부를 교육하고 안심시키

는 것이다. 이것은 산부가 감정적, 신체적 평안을 얻도록 하기 위함인데 교육과 훈련을 받고 진통 중 계속적으로 함께 있는 사람을 둘라(doula)라고 부른다.

둘라식 분만 간호는 1973년에 Raphael에 의해 처음 사용되었으며, 지속적인 신체적, 정서적, 정보적 지지를 제공하는 것을 말한다. 출산교육이 산전에 공포와 불안 및 스트레스를 감소시키기 위한 것이라면, 둘라식 분만 간호는 출산 중 산부의 옆에서 계속적인 간호를 함으로써 출산 중 공포와 불안 및 스트레스를 감소시키고자 하는 것이다. 둘라식 분만 간호는 미국과 캐나다를 중심으로 하여 과도한 의학적 중재의 출산에서 벗어나 자연출산을 권장하고 출산의 고통과 공포 및 불안을 감소시키고자 시작되었다.

4) 수중 분만법

목욕과 샤워는 고대로부터 통증을 완화시키기 위하여 사용했던 치료방법이며 최근에는 분만 시 통증을 완화시키는 방법으로 활용되고 있다. 역사적으로는 기원전 6세기 아리스토텔레스가 물을 생명의 근원이라고 하였으며, 1723년에 영국에서 발간된 『수중 치료(water cures)』라는 책에서 임신, 진통 및 출산에 대한 물의 효용성을 강조하였다. 또한 몇몇 부족들의 연구에 따르면 신전에서 수중 분만을 하거나 낮은 수위의 바닷물에서 출산한 기록이 있다. 현대적인 개념의 수중 분만은 유럽과 영국, 미국에서 관심이 증대되었고, 이에 대한 프로토콜도 개발되었다.

수중 분만법은 아기가 양수와 동일한 조건의 물속에서 태어나는 것을 기본원리로 하여 회음절개, 진통제, 촉진제 주사 등의 처치 없이 자연적으로 출산함을 말한다. 자궁수축부터 출산을 마칠 때까지 물 안에서 출산을 하거나 혹은 태아만출 시 분만대로 옮겨 태아만출을 할 수도 있다. 또한 수중 분만은 좌식 출산이므로 중력을 이용하여 골반이 쉽게 넓어지며 태아만출 방향과 중

력 방향이 동일한 장점이 있다. 일반적으로 수중 분만법은 은은한 조명 아래에서 이루어지며, 회음절개술은 가능한 한 하지 않고 출산 후 20초 내에 아기를 수중에 꺼내며 배우자가 탯줄을 절단하도록 한다.

수중 분만이 모체에 미치는 영향은 산부의 이완, 분만 통증 감소, 진통 및 출산시간 단축, 혈압 상승 억제, 그리고 모체와 신생아 간 유대감 증진 등을 들 수 있다. 수중 분만의 단점은 태아 및 모성 감염의 위험성에 대한 우려이며, 태아전자감시기를 부착하기 어렵기 때문에 지속적인 태아 감시가 어렵다는 것이다.

Simikin(1995)은 체내 순환하는 옥시토신 효과를 위해 분만활동기에 물에 들어가야 하고, 물 온도는 36.6~37.8°C로 유지하는 것이 편안함을 도모하고 임부의 체온 상승을 예방할 수 있는 방법이라고 하였다. 이때 간호사는 산부의 체온을 지속적으로 측정하여야 한다. 또한 태아의 심박동수를 모니터하기 위해 방수 도플러를 이용하여야 하며, 신생아나 모체의 감염 가능성을 감소시키기 위해 물의 청정도를 유지하는 엄격한 프로토콜을 적용해야 한다.

5) 르봐이에 분만법

르봐이에 분만법(Leboyer birth)은 고통과 폭력이 없는 출산방법에 대한 고민에서부터 시작되었다. 이 분만법은 의료인과 산부 중심의 출산에서는 아기의 입장이 전혀 고려되지 않았음을 반성하면서 제시되었다. 태아는 자궁 내에서도 소리와 빛에 반응하고, 미각을 느낄 수 있다는 연구 결과를 바탕으로 태아에게 출산 환경은 너무 폭력적이므로 신생아의 고통을 최소화하는 방법을 고안하였다. 막 태어난 아기에게 자궁과 비슷한, 너무 환하지 않은 조명과 조용한 환경을 제공하며, 제대 절단도 제대 박동이 멈춘 후 5분 정도에 해야 한다는 것이다.

르봐이에 분만법에서 고려해야 하는 점은 첫째, 출산

중 소음의 최소화, 둘째, 분만실의 조명도 낮추기, 셋째, 출산 후 바로 제대 절단을 하지 않고 아기가 엄마 배 위에서 모유를 먹을 수 있도록 하는 것이다. 이는 새로운 생명 탄생의 경이로움과 자연스러움을 강조하고 신생아, 산부, 아버지 및 의료진 모두가 함께 생명의 탄생을 경험하도록 하기 위함이다.

6) 그네 분만법

유럽에서 사용하는 방법으로 자궁수축이 시작되면 그네에 앉아 골반을 앞뒤로 흔들면서 직립 자세에서 출산하게 되는 장점이 있다. 일반 출산에 비해 통증이 적고 수중 분만이 불가능한 간염 보균자에게도 적용할 수 있다는 장점이 있으나, 아직 과학적인 뒷받침이 되는 연구가 충분치 않다는 제한점이 있다.

7) 출산 및 부모교육의 주제

Alden과 Harris(1995)는 출산 및 부모교육의 주제는 기관에 따라 조금씩 차이가 있지만 대부분 비슷한 내용과 효과를 보인다고 하였는데 이를 ICEA(International Childbirth Education Association, 국제출산교육협회)에서 제시하는 출산교육의 주제와 비교하면 표 4-I-36과 같다.

출산교육 프로그램에는 정상임신과정, 임신 중 식이, 운동, 성생활, 불편감 관리, 조산 및 위험증상 대처방법 등의 자가간호에 대한 내용을 포함한다. 출산과 관련하여 정상분만과정, 분만 통증 조절방법, 다양한 분만방법 및 배우자의 역할, 그리고 산육 관련 내용으로는 산육 생리 및 회복에 대한 내용을 포함한다. 또한 정상 신생아의 생리, 신생아 돌보기, 모유수유 및 유방관리 등의 내용을 포함한다.

표 4-I-36. 출산 및 부모준비 교육에서 주로 다루는 주제

Alden과 Harris	ICEA
• 수정, 태아발달, 임신의 개괄적 이해 • 임신 중 영양요구와 식이 계획 • 임신 중 불편감 관리 • 병원이나 출산에 대한 일반적 정보 • 분만의 과정에 대한 설명 • 모유수유, 인공수유, 포경, 모자동실 등 관심 주제에 대한 논의 • 분만과정을 조절하는 방법에 대한 설명 • 분만 중 산부와 코치, 건강관리자의 역할 • 의학적 관리, 태아 감시, 겸자분만이나 흡입분만, 유도분만, 제왕절개, 회음절개술에 대한 설명 • 산후 관리 • 신생아의 특성 및 행위 • 신생아 관리 • 부모 됨	• 인간 생식의 해부, 생리 및 임신, 분만, 산육생리 • 임신 중 영양과 태아 발육과의 관계 • 임신, 분만 산육시기의 자가간호와 안위 도모를 위한 방법 • 분만, 출산 시 동반자의 역할과 지지방법 • 가족의 사회적, 심리적 역할과 관계 • 분만, 출산, 산육기 관리 시 건강관리 제공자의 역할 • 분만, 출산과정, 출산환경의 선택 • 예비가족의 관리 • 고위험분만 • 양육을 위한 준비 • 병원 분만실, 신생아실 견학

2. 산전교육프로그램의 실제

1) 임신 관련 교육

(1) 태교

우리나라 임부는 어떤 형태로든 태교에 관심을 두고 있으며 나름의 태교를 하고 있는데, 무엇보다도 태교의 기본적 의미를 아는 것이 중요하다. 태교는 부모가 되기 위해 신체적 건강을 유지하는 것뿐만 아니라 심리적 안정 및 올바른 마음가짐을 갖기 위함이며 더 나아가 태아와의 교감을 통해 부모-자녀 간 관계를 만드는 것이다.

신생아는 자궁 내에서 촉각, 시각, 청각, 화학적 감각 등이 발달되고, 외부환경에 민감하여 오감이 반응을 하며, 습관성, 고전적 조건형성 등으로 학습능력이 있다고 알려져 있다. 특히 임부의 스트레스가 태아 및 신생아에게 영향을 미치므로 태교에서 가장 강조하는 것은 임부를 정서적으로 안정시키고 임신 중 스트레스를 예방하는 것인데 실제로 이에 대한 과학적 근거들이 제시

된 바 있다.

임신 초기에는 임부가 어떤 태교를 하고 있으며 무엇이 적절한 태교방법인지에 대해 논의하는 것이 도움이 된다. 박금자(2001)는 태교에 사용되는 방법들을 청각태교, 시각태교, 음식태교로 구분하였다. 청각태교방법으로는 세 가지를 제시하였는데 음악태교는 임신시기에 따라 음악을 청취하는 방법이며, 태담태교는 태아와의 대화를 통한 태교, 그리고 부성태교는 남편과 태아가 대화를 매일 갖는 태교라고 하였다. 시각태교방법은 임신 중 시각감각을 자극해 긍정적인 느낌을 많이 받도록 하는 것으로서, 좋은 책을 보거나 명화·영화를 감상하는 태교를 말한다. 또한 적절한 음식 섭취를 통해 섭생에 유의하는 음식태교가 있다. 이 밖에 임신부에게는 생활의 활력을 주고 태아에게는 충분한 산소공급으로 뇌활성화를 돕는 운동태교 등 여러 가지 태교방법이 소개되고 있다. 의료진이나 간호사가 태교에 대한 이해를 공유하고 태교의 영향에 대한 과학적, 경험적 근거를 바탕으로 임부 교육 프로그램을 발전시킬 필요가 있다.

(2) 식이

임신 중 식이는 임부와 태아의 건강에 직접적인 영향을 주기 때문에 매우 중요하다. 임부는 5대 영양소를 골고루 섭취해야 하며, 양보다는 식이의 질이 중요하다는 것을 교육한다. 특히 임신 초기는 입덧으로 섭취량이 적을 수 있지만 요구량이 많지 않은 시기이므로 조금씩 자주 먹도록 권한다.

임신시기별 영양관리를 포함하여, 5대 영양소가 들어 있는 구체적인 식품에 대한 소개가 필요하다. 특히 부족하기 쉬운 철분과 엽산 보충에 대한 교육도 필요한데 엽산은 임신 전에 복용을 시작해야 하므로 가임 여성을 대상으로 홍보가 선행되어야 한다. 뿐만 아니라 임신 중 나타날 수 있는 식이 문제의 대처방법과 제한해야 하는 음식에 대한 설명도 포함해야 한다. 알코올은 물론이고 카페인을 300mg 이내로 제한하며, 특히 카페인 섭취가 철분 흡수를 방해한다는 점도 설명한다. 임신 중 변비나 속쓰림, 입덧 등이 흔히 나타나는 문제이므로 이를 예방하기 위한 식이에 대해서도 교육한다.

(3) 운동

출산 및 부모교육에서는 산전운동에 대한 정보를 제공한다. 임신 중 안위감을 증진시키고 출산을 준비하기 위하여 근육을 강화하는 훈련이 필요하다. 임부의 건강 수준에 따른 적절한 운동을 지도하고 운동 전 준비사항, 운동 중에 발생할 수 있는 위험증상, 운동 후 휴식 등을 구체적으로 알려주어야 한다. 일반적으로는 적절한 자세 유지, 모체의 상해 예방, 태아 건강증진을 위한 걷기 및 앉거나 물건을 드는 방법 등을 교육한다. 배우자와 함께 공기 좋은 곳에서 산책을 하는 것은 임부에겐 적절한 운동이며 동시에 배우자와도 좋은 대화의 시간을 가질 수 있어 권장할 만하다. 수영은 많은 임부들이 관심을 갖지만 너무 뜨거운 온천물이나 차가운 물에서의 수영은 금하도록 교육한다.

(4) 성생활

임신 중에 성생활을 반드시 제한하지는 않는다. 오히려 적절한 성생활은 부부간의 정신건강을 위하여 필요한 요소이다. 그러나 임신 초기에는 유산 가능성이 있기 때문에 과격한 성행위는 제한한다. 특히 유산이나 조산 경험에 있는 경우와 부부 모두가 심리적으로 부담을 갖는 경우에는 성생활을 제한할 수 있다. 임신 중기와 후기에는 임부의 복부 증대로 인한 불편감을 극복할 수 있도록 적절한 체위에 대한 교육이 필요하다. 성적 자극이 자궁수축을 유발할 수 있으므로 임신 후기에 조산의 우려가 있는 임부에게는 이에 대한 주의점을 알려준다. 또한 출산 후 성생활 시작시기에 대한 내용도 교육에 포함한다.

(5) 불편감 및 위험증상 관리

임신과정에서 겪는 일반적인 불편감과 위험신호 및 증상을 감별할 수 있도록 교육한다. 대부분의 불편감은 임신이 진행되면서 정상적으로 나타나는 증상들이므로 임부가 이를 긍정적으로 받아들이고 최대한으로 경감시킬 수 있도록 적응방법을 알려준다.

조기 자궁수축, 출혈, 감염, 태동변화 등의 위험증상 및 그에 따른 대처방법과 의료진의 연락처를 구체적으로 알려줌으로써 임부와 배우자가 위험상황에 적절히 대비할 수 있도록 한다. 예를 들어 상당수의 임부들은 조기 자궁수축의 징후로 나타나는 요통과 같은 증상을 간과할 수 있기 때문이다. 또한 태동을 매일 일정한 시간에 측정하게 함으로써 태아의 안녕상태를 확인할 수 있도록 한다.

(6) 기형아 예방

기형아 발생은 점차 증가되고 있지만 그 원인은 아직 정확히 밝혀져 있지 않다. 간호사는 임신을 준비하는 부부에게 임신 전부터 흡연, 음주, 약물 남용을 피하도

록 설명해야 한다.

임신 중 기형아검사는 임부 면담을 통한 연령, 가족력, 임신력, 출산력 등의 사정과 혈청 표지물질에 대한 검사이다. 대표적인 기형아검사는 보통 임신 15주에서 20주 사이에 모체혈청을 채취하여 검사하는 모체 알파 피토프로테인검사(maternal serum α -fetoprotein test)이다. 모체 알파피토프로테인은 이분척추와 같은 중추신경계결손(neural tube defect)을 갖고 있는 경우에 증가하고 반대로 다운증후군, 에드워드스증후군과 같이 삼체성 염색체를 가지고 있는 경우에는 정상보다 감소한다.

그외 혈청 융모생식샘자극호르몬검사(human chorionogonadotropin test), 비접합에스트리올검사(unconjugated estriol test) 등이 있으며, 이 세 가지 표지자검사를 삼중표지자검사(triple marker screening test)라고 하며 근래에는 삼중검사에 inhibin-A 검사를 추가하여 사중검사를 시행하기도 한다.

또한 임신 중에는 기형 발생 가능성이 있는 방사선 조사, 흡연, 음주, 고열, 약물복용, 환경오염, 영양부족 및 독소플라스마증, 간염, 풍진, 단순포진, 매독 등의 모체 감염과 같은 환경적 요인을 피하도록 정보를 제공한다. 특히 TORCH 감염(toxoplasmosis, others, rubella, cytomegalovirus, herpes)은 태아 손상의 위험이 높으므로 예방이 필수적인데 독소플라스마(toxoplasma)를 예방하기 위해서는 털 익은 육류 섭취를 피하고, 고양이와 같은 집에서 기르는 동물과의 접촉을 피하도록 한다. TORCH 감염 중 기타 감염(others)은 매독, 베타 연쇄상구균(β -streptococcus), 헤르페스 조스터 바이러스(herpes zoster virus), 간염(hepatitis virus), 인간면역결핍바이러스(human immunodeficiency virus)에 의한 감염 등을 말한다. 베타 연쇄상구균은 최근 임부의 조기진통, 조기양막파수, 융모양막염, 산욕기 패혈증 및 태아와 신생아의 감염과 관계가 있는 것

으로 보고되고 있다.

기형아 예방차원에서 환경적 요인, 유전적 위험성이 있는 경우에 유전상담, 기형아의 조기발견을 위한 임신 중 진단 및 처치, 출산 후 진단 및 처치 등을 포함하는 교육도 이루어져야 한다.

2) 출산 관련 교육

(1) 정상분만과정에 대한 교육

① 입원에 대한 일반적 소개

출산을 위한 입원에 필요한 모든 정보를 제공한다. 입원 시 준비물품, 자궁수축 시작 시의 연락방법, 교통 수단 확보, 집에서 병원까지의 거리, 응급 시 후송방법 등을 구체적으로 준비할 수 있도록 안내한다. 가능한 경우 미리 분만실 및 신생아실을 방문할 수 있도록 해당 부서와 협의한다.

② 분만 증상 및 분만과정에 대한 설명

이 시기의 교육은 분만이 가까워움을 알리는 증상과 분만과정에 대한 개괄적인 설명, 그리고 분만과정에서 겪을 수 있는 증상을 포함한다. 분만과정은 정상적인 과정이며 이 과정에 태아도 적응해야 함을 설명한다.

(2) 분만통증을 조절하는 방법

분만통증을 완화하는 여러 가지 기술이 있으며 연상법(imagery), 이완법(relaxation), 치료적 접촉(therapeutic touch), 마사지, 음악, 호흡법, 지압(acupressure), 아로마테라피(aromatherapy) 등이 주로 쓰이고 있다.

① 연상법

연상법은 산부에게 출산과정과 출산에 대한 신체, 정신적인 사건을 느끼도록 하거나 또는 정신적인 상상을 통해 출산 과정에 저항하기보다는 오히려 참여하도록

만드는 방법이다. 간호사는 출산과정 동안 마음과 신체 의 연결을 강화하는 심상요법을 사용하는데, 예를 들면 자궁수축은 신생아를 위해 자궁문이 열리는 것으로 상상 하게 하고, 호흡은 신선하고 깨끗한 산소를 태아에게 전달하고 노폐물과 긴장을 제거해주는 것으로 생각하며, 신생아는 산도를 따라 내려오고 있다고 상상하게 한다.

간호사는 조용하고 진정된 목소리로 대화를 나누며 이완과 심상을 방해하는 환경적 자극을 제거하고 이러한 기법을 배우자나 지지자에게 설명함으로써 산부가 조용하고 좋은 장면을 상상할 수 있도록 한다. 간호사는 이완훈련, 즐거운 상상, 감각 전이(sensory transformation) 등을 사용하여 산부가 평온하고 평화로운 상상을 하도록 지지한다. 즐거운 상상이란 조용한 곳에 앉아서 즐거웠던 일을 생각하고 음악을 듣거나 책을 읽을 때 바닷가의 아름다운 경치를 상상하며 감각을 전이 해보는 것이다. 감각 전이는 출산의 통증을 즐거웠던 느낌으로 바꾸어보는 것을 말한다. 산부에게 눈을 감고 편안한 자세로 폭신한 베개에 기대어 눕거나 아름다운 것을 상상하게 한다. 이것은 엔돌핀의 분비를 증가시킨다.

서양에서는 파도 치는 소리, 조용한 해변가, 애인과 거닐었던 추억, 갈매기가 날고 뭉게구름이 스쳐가는 아름다운 광경을 연상하지만 우리나라는 고요한 산사의 풍경소리, 목탁 소리, 새소리, 시냇물 흐르는 소리 등을 연상할 수 있다.

② 이완법

출산 중 고통스러운 자극에 대한 생리적 반응은 출산의 진행과 통증 감지 정도에 영향을 준다. 불안이나 통증은 카테콜라민(catecholamines epinephrine과 norepinephrine)을 증가시켜 자궁수축과 혈액순환, 그리고 출산 지연을 초래하게 된다.

산부의 몸이 충분히 이완되어 전신의 근육긴장도가

낮아지면 에너지 소모가 감소되고, 통증과 불안이 감소된다. 이완은 출산을 용이하게 하므로 임신 중 이완을 연습하는 것이 필요하다. 방을 편안하고 안락하게, 실내온도는 적당히 조절하며, 실내를 조용하게 하고, 편안한 음악을 틀어놓는 방법도 좋다. 이완법을 연습하기 위해 코치가 언어나 접촉을 통해 지시할 수 있으며, 바이오피드백(biofeedback)이라는 기계를 이용하여 이완 정도를 보면서 이완하는 법을 연습할 수도 있다.

③ 치료적 접촉

훈련받은 기술자는 손을 펴서 심신의 긴장을 풀고 촉각을 집중한다. 산부의 몸에서 2인치 떨어져 머리로부터 복부, 발 쪽으로 천천히 내려가며 체온, 압력, 중압감, 미는 힘 같은 것을 감지한다. 그리고 두 손으로 쓸듯이, 위에서 아래로 반복해서 여러 번 실시한다. 이 훈련은 긴장을 이완시켜주는 효과가 있다고 한다.

④ 마사지

마사지는 손을 이용해서 근육을 이완시키고 신경을 안정시키며 혈액순환을 도모하는 방법이다.

마사지는 피부나 근육의 전신 혈액순환의 개선, 근육의 흥분과 진정, 신경, 근육, 내장 등에 간접적으로 자극을 가하여 기능을 회복시키는 반사작용 효과와 전신 자율신경이나 내분비선 조절효과, 내장기능 회복효과도 있다. 출산 중 사용하는 마사지로는 쓰다듬기, 주무르기, 압박법, 반대압박법 등이 있다.

경찰법(effleurage or stroking, 쓰다듬기, 가볍게 두드리기)은 손바닥을 편평하게 하고 손가락은 약간 구부려 근육이나 피부 표면을 쓰다듬고 어루만지거나, 또는 가볍게 두드리는 방법으로서 전신의 어느 부위라도 가장 손쉽게 실시할 수 있는 방법이다. 대상자의 몸에 손을 대고 보통 5~6kg의 압력을 가하면서 혈관이나 림프관의 흐름에 따라 말초에서 중추부로 쓰다듬거나

가볍게 두드리는 기술이다.

유날법(petrissage, 주무르기)이란 주로 근육을 손으로 집어 주무르는 방법이다. 대상자의 피부에 손을 밀착하여 보통 5~10kg 정도의 힘으로 근육을 쥐듯이, 또는 손가락 안을 대고 힘을 가하면서 동그라미나 타원상으로 움직이면서 근육 안의 혈액을 짜내는 듯한 느낌으로 주무른다.

압박법(compression)은 지압과 비슷한 것으로 엄지손가락 앞부분의 부드러운 곳으로 누르는 기술인데 상태에 따라서 두 엄지손가락을 겹쳐서 사용하기도 하며 손바닥 전체를 사용하기도 한다. 심장의 먼 곳에서 가까운 곳을 향해 실시하는데 너무 깊고 강한 압박은 산부를 고통스럽게 하고 지치게 하므로 주의한다. 가능하면 아프지 않게 서서히 3~5초간 지그시 무겁게 누르는 것이 좋으며 치료사와 대상자가 호흡을 같이 하는 것이 바람직하다. 가볍고 빠른 누름은 근육에 자극을 주어 기능을 증진시키고, 깊고 지속적인 누름은 조용하고 차분함을 가져와 안정을 준다.

반대압박법(counterpressure)은 압박하는 부위의 반대편을 지지한 상태에서 손바닥을 이용하여 압박하는 방법으로 주로 등을 눌러주는 것을 말한다.

⑤ 음악

음악요법은 미리 준비한 음악을 이어폰을 통하여 듣는 것이다. 산부가 듣고 싶어하는 음악을 선정하여 듣게 함으로써 주의집중, 주의전환과 호흡법 적용에 도움이 될 뿐 아니라 근육이 이완되고 불안이 감소한다.

분만 초기에는 느리고 이완되고 조용하며 속도가 크기에 별로 변화가 없는 음악을 사용하고, 신체적인 노력이 필요한 분만 후기에는 안정된 비트의 음악을 들도록 한다. Liu, Chang 등(2010)은 음악요법은 분만 초기에 분만 통증과 상태불안을 감소시켜주는 효과가 있다고 보고하였다.

⑥ 호흡법

호흡법은 흉식호흡이나 복식호흡을 통해 호흡양상을 조절하는 것이다. 라마즈 분만법에서는 흉식호흡을, 소프롤로지 분만법에서는 복식호흡을 권장한다. 이에 대한 것은 출산교육의 종류에 제시되어 있다.

⑦ 지압(指壓)

최근 서양의학에서도 동양의학인 침술과 지압법을 적용해보려는 시도가 많다. 아직 과학적으로 증명될 만큼 완전한 체계를 이룬 것은 아니지만 아마나 지압이 산부의 불편감 완화나 진정 및 진통에 효과적이라는 것이 실험적 연구로 증명되고 있다.

지압은 동양의학의 치료법 중 한 가지로 손가락 끝이나 엄지로 신체의 특정부위를 눌러 자극하는 방법이다. 지압 부위로는 신체 표면에 분포해 있는 수혈(輸血) 부위 중 몇 개의 혈(穴) 부위를 택한다. 혈 부위를 자극하면 경락을 격발시켜 기혈(氣血) 운행의 기능을 촉진시키고, 자체 조정능력을 개선하며, 질병 방지 및 질병 퇴치의 기능이 작동된다.

사람의 수혈에는 12경맥과 임맥, 독맥 등의 14경혈과 기혈, 아시혈(阿是穴)이 있다. 14경혈을 통해서는 혈이 있는 부위 및 주위 조직기관의 국소부위와 기혈이 미치는 먼 부위, 즉 내부장기의 병증을 치료할 수 있고, 어떤 것은 전신에 영향을 주기도 한다. 기혈은 14경혈에 속하지는 않지만 어떤 질병에 특수한 치료작용이 있는 혈이다. 아시혈은 구체적인 명칭과 고정된 위치가 없고 압통점 혹은 기타 반응점을 수혈로 하는데, 예로부터 “이통위수(以痛爲輸)”, 즉 “아픈 자리가 곧 취할 혈이다”라고 하였다.

지압에는 혈위(穴位, 壓點 : pressure point)를 선택하여 손가락 끝이나 엄지로 꼭 눌러주거나, 손가락을 아주 약간 돌리며 힘을 주는 방법이 있다. 누르는 강도는 지압을 받는 사람의 느낌에 따른다. 지압점을 정확

하게 누르면 대상자는 저릿한 느낌(tingling)이나 압통(tenderness)을 느끼게 된다. 혈, 즉 지압점이 뼈 위에 위치하는 것은 아니지만 뼈를 향해서 누른다. 한 번 누를 때 3~10초간 누르고 반복 실시한다. 지압점을 가볍게 마사지하면 심부근층에까지 자극의 효과가 확산된다. 지압의 기전은 혈 주위의 신경을 자극하여 신경기능을 조절하는 것이며, 엔돌핀의 분비작용 및 관문 통제에 의한 통증을 감소시키는 작용을 한다고 추정된다.

임신과 분만 중에 사용할 수 있는 지압법에는 다음과 같은 것이 있다.

• 임신 불편감의 해소

임부들은 대부분 임신 초기와 중기에 경한 불편감을 경험하므로 활용할 수 있는 지압법을 알고 있는 것이 도움이 된다.

• 현기증이나 기절했을 때

손가락 끝으로 인중(人中 : 수구 水鉤)을 누른다. 인중은 코와 윗입술 중앙부에서 상 1/3과 중 1/3의 인접부위이다(그림 4-I-45).

• 두통

태양혈 부위(관자놀이)를 엄지로 눌러준다. 이곳은 두통에 가장 많이 사용되는 곳으로 눈썹 끝과 눈 외측 중간 뒤로 약 1촌 밖 오목한 곳이다. 이곳은 기혈에 속한다. 태양 부위의 지압은 혼자서도 할 수 있다. 풍지혈위

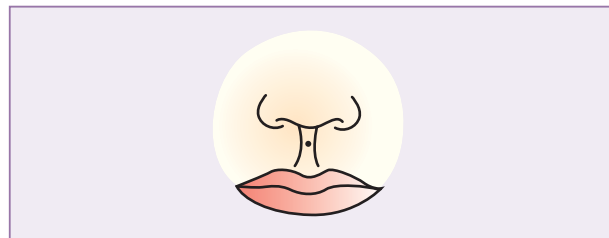


그림 4-I-45. 인중(수구) : 기절했을 때의 지압점

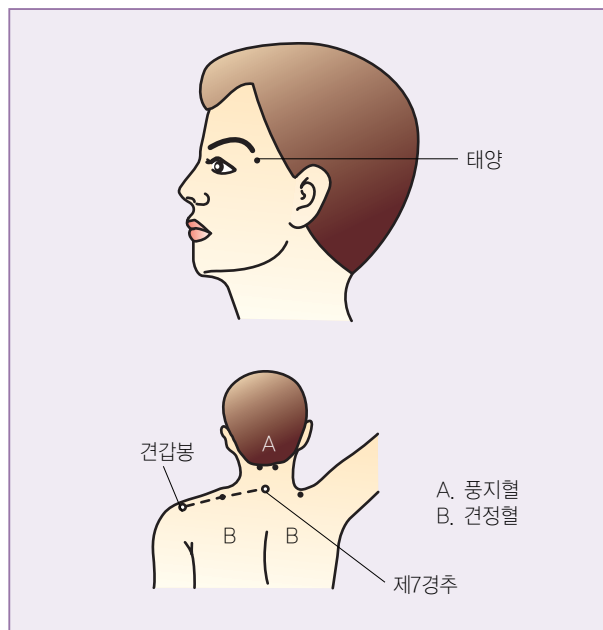


그림 4-I-46. 두통 시 지압점

(風池穴位)를 엄지나 손가락 끝으로 꼭 눌러도 효과가 있는데 풍지혈위는 제1경추 양옆, 두부 바로 아래에 위치한다. 제7경추와 견갑봉의 중간, 즉 어깨 위에 있는 견정혈위(肩井穴位)를 지압하여도 두통을 완화할 수 있다. 지압을 3~5초간 반복하면 두통 완화에 특별한 효과가 있다. 풍지와 견정부위는 두 사람이 앉아서 하는데 지압시술자가 환자의 뒤에서 실시한다(그림 4-I-46).

• 좌골신경통과 하지경련

좌골신경통과 하지경련은 임신 말기에 흔한 불편감이다.

좌골신경통 완화를 위해 상전장골극(anterior superior iliac spine)으로부터 5cm 위와 대좌골절흔(greater sciatic notch) 주위를 지압한다. 이 지압점은 분만 동안 요통을 완화하는 데 유용하다(그림 4-I-47).

하지경련의 완화는 하지 뒤쪽의 위중(委中), 승산(承山), 곤륜(昆侖) 위를 눌러주거나 경찰(stroking)하고,

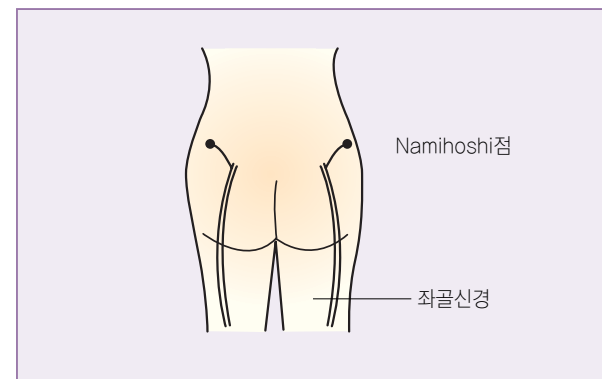


그림 4-I-47. 좌골신경통 지압점

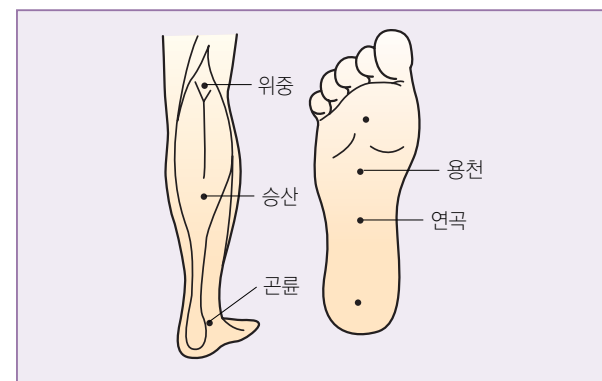


그림 4-I-48. 하지경련 지압점

발바닥 위의 지압점을 눌러준다. 위중은 무릎 뒤 오목한 부분의 중심부이며, 승산은 비장근 양근 사이 오목하게 들어간 곳의 끝 주위이고, 곤륜혈은 외측 복숭아뼈와 근건 사이 오목한 곳이다(그림 4-I-48).

• 출산 중의 통증조절과 이완

지압은 통증조절과 진정(analgesia and sedation)에 도움이 되는 물질을 산출하여 출산의 통증을 조절한다. 전신에 분포된 혈위를 모두 지압하면 전신이 점진적으로 이완되며, 이완상태의 질을 높이고 온몸을 더 깊게 이완하게 한다.

지압을 받는 사람을 편안하게 엎드려 눕게 하고 지압

시술자는 앉아서 머리, 목, 견갑위의 지압점에서부터 시작하여 척추의 양옆을 따라 아래로 내려가면서 혈위를 꼭 눌러준다. 척추 양옆의 대표적 혈위에는 제1흉추 옆의 심유(心俞), 제9흉추 옆의 간유(肝俞), 제12흉추 옆의 위유(胃俞), 제1요추 옆의 삼초유(三焦俞), 제4요추 옆의 신유(腎俞), 제4요추 옆의 대장유(大腸俞) 등이 있다. 등을 지압할 때는 견갑골의 견정혈위부터 시작한다. 지압은 근육 위를 조심스럽게 눌러주고 척추뼈 위는 직접적으로 누르지 않는다. 압박은 3~5초간 자주 반복한다. 혈위는 대개 척추에서 1인치 떨어진 아래 부위를 누른다.

위에서부터 지압하며 내려오다가 장골능(iliac crest) 위치에 오면 장골능을 따라서 바깥쪽으로 눌러준다. 다리의 지압점은 대퇴 뒤쪽 중앙에서 하지 쪽으로 내려가면서 엄지로 눌러주거나 경찰하고, 발바닥은 엄지로 꼭 눌러준다.

팔의 지압은 어깨로부터 팔의 위쪽 중앙부를 따라 아래로 내려오면서 지압하거나 마사지한다. 특히 손목 위 2인치 지점의 외관혈위(外官穴位)를 눌러주면 이완이 더 잘된다. 팔의 마지막 지압점으로는 외관혈위가 적절한데 이는 손을 이완하고 불안을 완화하는 효과가 있다. 이 지압점은 특히 출산 동안에 더 유용하다(그림 4-I-49). 손바닥의 3전(손의 기초 중앙점, 손바닥의 중앙, 중지 바로 밑 중앙점)은 손을 이완하는 데 유용하다(그림 4-I-50).

산부들은 출산 1기의 활성화에 강한 자궁수축이 오면 손을 꼭 쥐거나 무언가를 쥐어 찐다. 이때 손바닥과 함곡(合谷 : Ho-ku point) 부위를 지압하거나 마사지해 주면 둔부, 다리, 발 및 손의 긴장을 해소하여 출산의 고통을 완화해 줄 수 있다. 발바닥의 마사지점은 발 뒤측 부위인데, 이 부분을 꼭 눌러주면 신체 하부를 이완하는 데 도움을 준다.

함곡점은 엄지와 집게손가락 사이가 끝나는 점으로

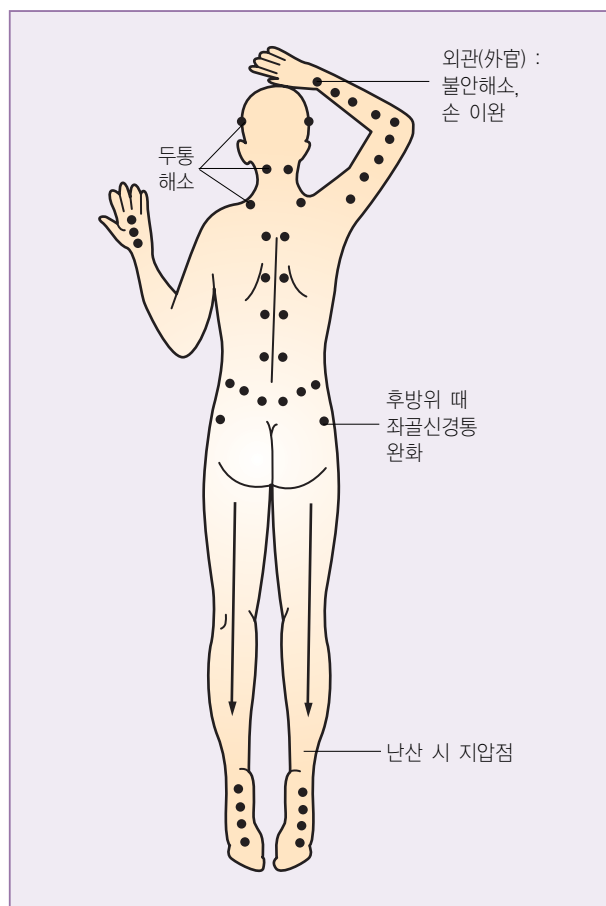


그림 4-I-49. 등 마사지를 위한 지압점

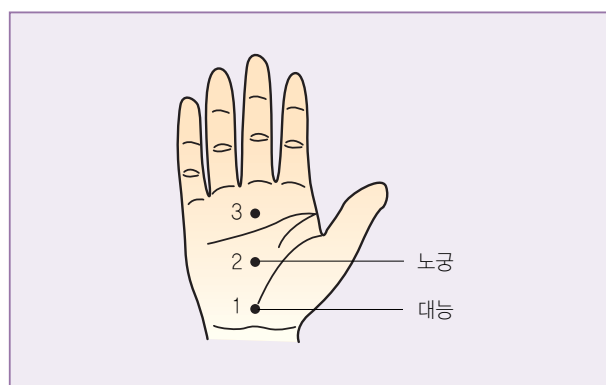


그림 4-I-50. 손바닥 지압점

두통을 완화하고 편안함을 높여준다. 엄지와 집게손가락을 이용하여 부드럽게 압박한다(그림 4-I-51). 임신 38주 이전의 임부에게 합곡을 지압하면 출산이 유도될

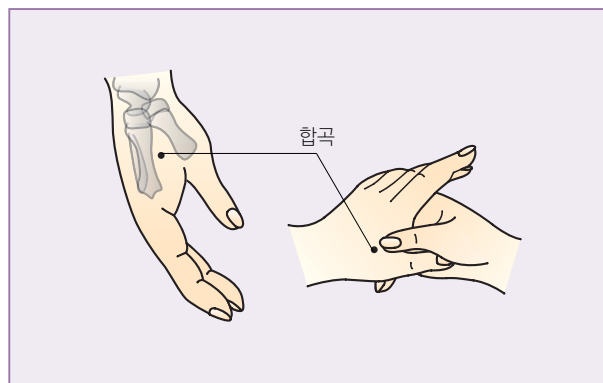


그림 4-I-51. 합곡 : Ho-Ku point



그림 4-I-52. 삼음교(San-yi-chiao point)

가능성이 있으므로 절대로 이용하면 안 된다.

삼음교(三陰交, San-yi-chiao point) 혈위는 난산을 위한 지압점이다. 삼음교는 내측 복숭아뼈에서 위쪽으로 네 손가락 높이의 위치이며, 경골 후면에 위치한다. 비효과적인 자궁수축으로 출산이 잘 진행되지 않을 때 이 부위를 지압하면 자궁수축이 순조롭게 촉진된다. 합곡과 함께 삼음교를 지압하면 출산을 유도하는 데 효과적이다. 삼음교도 임신 38주 이전에는 사용을 절대 금한다(그림 4-I-52).

이 외에도 출산 시에 요통을 호소하는 부위가 곧 아시 혈위로서 지압점이 되므로 산부가 아프다고 가리키는 곳을 엄지나 손가락으로 꼭 눌러주거나 마사지해주면 통증이 완화된다. 자궁이 수축될 때 동시에 지압이나

표 4-I-37. 임신 중 피해야 할 에센셜 오일

angelica	melissa
hyssop	spanish Marjoram
peppermint	clary
aniseed	myrrh
jasmine	sweet marjoram
rosemary	clove
basil	marjoram
juniper	tarragon
savory	cinnamon
camphor	origanum
lovage	thyme
sage	fennel
cedarwood	parsley

마사지를 해주는 것이 더 효과적이다.

합곡과 삼음교의 두 점이 자극되었을 때 통증 없이 수축을 증가시킬 수 있다고 한다. 이 점은 매우 주의를 요하는 곳으로 손가락으로 10에서 60초 동안 누르고 같은 시간 쉬어야 하며 6회 이상 반복한다. 이 지압점은 임신 동안 자극되면 안 되므로 주의해야 한다. 지압은 식후 1시간이 지난 다음 실시하며, 지압 부위에 피부병, 발적, 종창, 균열 등의 염증증상이 있을 때는 절대 금기이다.

⑧ 아로마테라피

아로마테라피는 새롭게 조명되는 보완요법 중의 하나로 최근 연구가 활발하게 진행 중이다. 그러나 아직 임

상적으로 사용되는 데는 한계가 있으며 효율적인 중재를 위해 과학적인 연구가 수행되어야 한다.

아로마테라피 효과는 스트레스를 감소시키고, 이완하게 하며, 피로감, 통증, 그리고 임신 중 불편감을 경감시키는 효과가 있다. 그러나 에센셜 오일 중에는 독성을 가진 것도 있어서 임산부가 아로마테라피를 받을 경우 반드시 전문 아로마테라피스트의 지시를 따라야 한다.

임신 중 사용할 수 있는 에센셜 오일은 만다린(mandarin=citrus nobilis), 네롤리(neroli=citrus aurantium) 등이 있으며, 피해야 할 에센셜 오일은 표 4-I-37과 같다.

출산 중 사용할 수 있는 대표적 에센셜 오일로는 클라리세이지(clary sage=salvia s clarea), 제라늄(geranium=pelargonium graveolens), 재스민(jasmine=jasminum officinale), 라벤더(lavender=lavandula officinalis), 만다린(mandarin=citrus nobilis), 네롤리(neroli=citrus aurantium), 로즈(rose=rosa damascena), 일랑일랑(ylang-ylang=cananga odorata) 등이 있다. 이 에센셜 오일이 산부의 특성에 따라 적절히 블렌딩되었을 때는 출산에 매우 효율적이다. 표 4-I-38은 임신 및 분만 중 사용하는 아로마테라피의 예이다.

(3) 다양한 분만방법

대부분의 산부는 정상적인 질식 분만을 하지만 유도 분만, 제왕절개분만을 하게 될 가능성도 배제할 수 없

표 4-I-38. 임신 및 분만 중 사용하는 아로마테라피의 예

임신	진통
antistretch mark oil	labor day massage oil
base oil - sweet almond oil 80ml	base oil - sweet almond oil 50ml
avocado oil 20ml	
essential oils - mandarin oil 7 drops	essential oils - lavender oil 6 drops
neroli oil 5 drops	jasmine oil 4 drops

다. 많은 산부들은 질식 분만에 성공하지 못했을 경우 죄의식이나 우울감에 빠질 수 있으므로 유도분만, 제왕절개분만 또한 정상분만의 한 과정임을 주지시켜 주어야 한다. 또한 회음절개술이나 태아 감시(fetal monitoring)에 대한 정보도 제공한다.

(4) 배우자의 역할

임신 및 출산 시에는 무엇보다 배우자의 역할이 중요하다. 임신 기간 동안 가사 분담 및 정서적 지지뿐 아니라 임부의 불편감과 분만 시 통증을 완화시키기 위한 정보를 제공하고 능숙하게 도울 수 있도록 반복된 훈련이 필요하다. 특히 산부가 불안정하거나 조절력을 상실하였을 때 명확한 지시와 긍정적인 지지를 할 수 있도록 훈련시킨다.

3) 산육 관련 교육

(1) 산육생리

출산 후 산육생리는 산모의 신체적 회복을 중심으로 교육한다(출산후 생리적 변화와 적응 참조).

(2) 산후조리

산육 관련 교육에서는 산후조리의 기본원칙에 대한 설명을 포함한다. 우리나라의 전통적 산후조리와 현대적인 산후조리를 과학적으로 설명할 필요가 있다. 산모의 선호도나 가족의 조언 사이에서 갈등이 생기지 않도록 산후조리 계획을 세워보는 것도 도움이 된다(표 4-I-39). 또한 산후 식생활과 금연, 금주 및 모유에 영향을 미치는 약물에 대한 교육도 포함되어야 한다.

(3) 산후운동

산후운동은 임신에서 출산에 이르는 동안 늘어난 근육을 원래의 상태로 회복시키기 위한 운동을 말한다. 산후운동을 함으로써 산모의 배뇨장애, 변비, 자궁퇴축

부전, 혈전성 정맥염 등의 합병증을 예방하고 회복을 촉진시킬 수 있다.

- ① 심호흡 : 폐에 공기를 가득 넣고 내설 때 배를 천천히 길게 끌어당긴다.
- ② 폐를 깨끗이 하기 위해서 깊이 호흡하고, 기침할 때는 골반중이나 복부의 수술 부위가 불편하지 않도록 복부 위에 베개를 올려놓거나 손으로 지지한다. 복부근육을 안으로 당기는 식으로 공기를 내뱉고, “와” 소리를 내면서 숨을 길게 들이마신다.
- ③ 발목 돌리기 운동 : 산전운동과 마찬가지로 발목을 붙들고 돌리며, 침상에서 일어나기 전에 발목운동을 하고 일어난다.
- ④ 다리운동 : 침대에서 일어날 때 발목을 서로 엇갈리게 쭉 펴고, 두 다리에 힘을 주어 침대에 무릎을 대고 엉덩이를 긴장시킨다. 몇 초간 긴장을 유지한 후 이완시킨다. 이것은 걸음걸이의 연습이 된다.
- ⑤ 무릎운동 : 무릎을 굽혔다 폈다 하면서 걷는 연습을 한다.
- ⑥ 골반저근 수축하기 : 케겔운동을 한다. 다음 임신 시 골반근육의 힘을 증진시키고 회음 부위의 혈액순환을 돕기 위해서이다.
- ⑦ 어깨로 버티고 서기 : 허리가 구부러지는 것을 방지한다. 뒷걸음질로 벽에 등과 발꿈치를 먼저 댄 후 엉덩이부터 어깨까지 벽에 기대다. 다시 앞으로 걸어 같은 동작을 반복한다. 출산 후 3~4일까지 하루에 2회 정도 하는 것이 좋다.
- ⑧ 골반 돌리기 : 늘어진 복벽에 자극을 주어 장의 활동을 자극함으로써 가스 배출을 쉽게 하며 혈액순환을 증진시킨다.
- ⑨ 몸의 회복상태에 맞추어 매일 가볍게 걸음을 걷는다.

표 4-I-39. 산후조리계획의 일례

- ▶ 1일
 - 소변을 가급적 빨리 본다.
 - 발한은 정상이다. 땀을 닦을 수건을 준비한다. 적당히 땀을 내도록 한다.
 - 누워서 쉽게 할 수 있는 체조를 24시간 내에 시작한다.
 - 회복을 위해 출산 후 조기이상이 필요하다.
 - 자극적인 음식, 딱딱한 음식, 찬 음식은 먹지 않는다.
 - 가능하면 아이에게 자주 젖을 물린다.
- ▶ 2일~3일
 - 따뜻한 물에 좌욕을 한다.
 - 퇴원준비를 한다.
 - 대변을 보았는지 확인한다. 분만 후 배변이 없었다면 의료진에게 알린다.
 - 이상신호가 있는지 관찰한다(열, 질 분비물 증가).
 - 유방마사지를 한다.
- ▶ 4일~7일
 - 아기와의 대화시간을 자주 갖는다.
 - 방의 온도는 따뜻하게 유지하고, 너무 덥거나 너무 춥지 않도록 한다.
 - 적절한 온도는 신생아에게도 필요하다.
 - 간단한 샤워는 무방하나 통목욕은 6주 후부터 가능하다.
 - 실내를 걸어다닌다.
 - 피로하지 않도록 한다. 피로하면 즉시 쉬도록 한다.
 - 가벼운 체조를 한다.
 - 긍정적인 사고를 하도록 한다.
 - 모유수유나 인공수유를 적극적으로 수행한다.
 - 신생아를 돌보는 데 주위 사람의 도움을 받도록 한다.
 - 도움을 받는다는 것에 스트레스를 받지 않는다.
- ▶ 2주~3주
 - 일어나 앉아 있는 시간을 늘린다.
 - 긍정적인 사고를 한다.
 - 신생아와 남편과 함께 대화하며 미래를 설계한다.
- ▶ 4주~7주
 - 몸에 특별한 이상이 없다면 정상적인 생활이 가능하다.
 - 자신의 에너지를 적절히 조절한다.
 - 무거운 것을 들거나 과도하게 피로한 일은 피한다.
- ▶ 8주
 - 임신 전 생활로 되돌아간다.
 - 성생활도 가능하다.
 - 성생활을 하는 경우 피임을 적극적으로 수행한다.

4) 신생아 관련 교육

(1) 신생아 돌보기

① 물품준비

태어날 아기에게 필요한 물품은 임신 7~8개월경에 준비하는 것이 좋다. 우선 필요한 것만 구입하고 아기의 성장에 따라 필요한 것을 준비한다. 아기 옷은 신축성이 좋아 입기 편하고, 세탁이 쉬우며, 부드러운 면 제품으로 된 것이 좋다. 보온성이 있는 것이어야 하고, 긴 옷은 앞이 전부 터져서 끈으로 여미는 것이 좋다.

② 신생아 예방접종

신생아 예방접종에 대한 교육은 최근의 자료를 확인하여 제공한다.

(2) 수유 및 유방관리

모유와 우유의 수유방법 및 장점에 대한 구체적인 교육이 필요하다. 모유수유율이 낮은 것은 모유의 장점을 모르기 때문이기도 하지만 모유수유 시의 어려움 때문이기도 하다. 그러므로 임신 중 모유수유를 위한 심리

적 안정, 유두 관찰 및 유방마사지 등의 교육이 필요하다. 또한 불가피하게 모유수유를 못하게 되는 경우 대상자가 죄책감을 느끼지 않도록 안심시키는 것도 중요하며 인공수유방법에 대한 내용도 포함해야 한다. 6단원의 모유수유에서 관련 내용을 참조하여 교육 내용을 작성하도록 한다.

5) 부모로의 전환에 대한 교육

아기를 갖게 되면 부모가 되며, 부부만의 생활에서 아이를 포함한 가족생활로의 변화가 필요하다. 이러한 변화는 즐거움과 환희를 주지만, 동시에 아이 양육에 대한 책임감으로 부모는 중압감과 스트레스를 느끼기도 한다. 흔히 부모들은 자신이 이 아이의 부모가 되기 위한 준비가 되었는지 반문을 하게 되며, 그에 대한 자신감 부족으로 스트레스를 받을 수 있다. 부모-자녀 간의 특별한 상호작용을 통해 부모는 자신을 되돌아볼 수 있을 것이다. 부모로의 전환과정에는 많은 자아성찰이 필요하다라는 점을 강조하고 깨달을 수 있도록 함께 토론하고 느낄 수 있는 시간을 가지게 한다.

핵심 문제

1. 자궁수축이 올 때 통증을 완화하기 위해서 적용하는 라마즈 호흡법을 분만 진행단계에 따라 설명하시오.